
QCM • CONCOURS

Concours de Recrutement des IDE 2ème Grade, CHU Oujda

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie
30 questions

Questions

1 L'incidence de crâne de face haute est :

- A Une incidence antéro-postérieure.
- B Réalisée chez un sujet assis avec un appui front-nez.**
- C Réalisée chez un sujet assis avec un appui sur le front.
- D Centrage est basé sur l'équidistance des deux conduits auditifs externes par rapport au plan de projection.**

2 Les critères de réussite d'une incidence de crâne de face haute sont :

- A Fentes sphénoïdales dans les orbites.**
- B Bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs.**
- C Distance apophyse orbitaire du malaire et table interne de la voûte latérale est identique des deux côtés.
- D Distance apophyse orbitaire du malaire et table externe de la voûte latérale est identique des deux côtés.

3 Incidence de crâne de profil :

- A L'angle formé entre le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de 15°.
- B Rayon directeur est horizontal.**
- C Le centrage est à 3cm au-dessus du tragus.**
- D Le centrage est à 3cm au-dessous du tragus.

4 Les critères de réussite d'une incidence de crâne de profil :

- A Superposition droite-gauche des planchers orbitaires.
- B Superposition des grandes ailes du sphénoïde.
- C Superposition des conduits auditifs externes.**
- D Superposition des apophyses clinoides.**

5 Incidence de HIRTZ :

A Le centrage est au niveau de la ligne bi-oculaire.

B Indiquée en cas de traumatisme du rachis cervical.

C L'angle formé par le rayon directeur et le plan sagittal marian est de 0° .

D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -150° .

6 Incidence de Worms-Bretton (incidence semi-axiale) :

A Le plan orbito-méatal oblique au plan de projection.

B Equidistance des deux conduits auditifs externes à la cassette.

C Les rochers sont situés largement au-dessus des rebords orbitaires supérieurs.

D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de 25° .

7 Incidence des os propres du nez :

A Incidence antéro-postérieure.

B Centrage à la base du nez.

C L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -30° .

D L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -70° .

8 Incidence Blondeau :

A Est une incidence qui permet d'analyser les sinus de la face.

B L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -50° .

C Nez est à 1cm de la plaque.

D Equidistance des conduits auditifs externes par rapport à la cassette.

9 Radiographie 3/4 (obliques) du rachis cervical :

- A** Patient en position debout ou assis en oblique postérieure du côté examiné.
- B** L'angle d'obliquité est de 45° à 60°.
- C** Rayon directeur est ascendant de 20°.
- D** Centrage sur la face latérale du cou, à hauteur de C2.

10 Radiographie des sacro-iliaques :

- A** Réalisée en décubitus avec membres inférieurs légèrement fléchis.
- B** Rayon directeur incliné vers la tête de 15 à 20°.
- C** Centrage à deux travers de doigt au-dessous du bord supérieur du pubis, sur la ligne médiane.
- D** Incidence antéro-postérieure.

11 Incidence de Chevrot :

- A** Incidence oblique, visualisant l'articulation sacro-iliaque dans le plan horizontal.
- B** Patient en décubitus, tronc fléchi en appui sur les coudes et membres inférieurs en extension.
- C** Bassin soulevé de 20° du côté à radiographier grâce à une cale en mousse.
- D** Rayon directeur est incliné de 30 à 50° vers les pieds.

12 Incidence de Lamy :

- A** Incidence permettant l'exploration de la ceinture scapulaire.
- B** Patient debout en oblique antérieure de 45 à 60° du côté opposé.
- C** Le bras est pendant, coude fléchi et légèrement porté en arrière.
- D** Rayon directeur est horizontal.

13 Les critères de réussite d'une incidence de Neer :

A	L'omoplate se présente sous la forme d'un « Y ».
B	L'écaille est vue de face.
C	L'articulation gléno-humérale bien dégagée.
D	Articulation acromio-claviculaire est visible.

14 Radiographie du coude de profil :

A	Patient assis, coude fléchi à 45° reposant sur la plaque par son bord interne, main verticale.
B	Rayon directeur est vertical.
C	Centrage au bord postérieur de l'épicondyle.
D	Centrage au bord postérieur de la trochlée.

15 Incidence de Schreck II :

A	Réalisée sur main fléchie en position d'écriture et en demi-supination à 25°.
B	Rayon incident est vertical.
C	Centrage à 1cm en avant de l'interligne radio-carpienne.
D	Incidence permettant l'analyse du scaphoïde.

16 Incidence de profil chirurgical de la hanche :

A	Profil d'Arcelin.
B	Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en extension.
C	La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur la cuisse.
D	La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté opposé.

17 Urographie intra-veineuse :

- A Peut être indiquée devant un syndrome obstructif urinaire.
- B Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices.
- C Est actuellement supplantée par l'uroscanner.
- D Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif.

18 Urétrocystographie rétrograde :

- A L'injection du produit de contraste est réalisée par voie intra-veineuse.
- B Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif lors du remplissage.
- C Un cliché post-mictionnel est indispensable.
- D Est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale.

19 L'incidence qui permet d'étudier l'apophyse zygomatique est :

- A Incidence de HIRTZ SUBAXIALE.
- B Worms-Bretton (incidence semi-axiale).
- C Incidence de crâne de face.
- D Incidence de crâne de profil.

20 En mammographie, le rayonnement diffusé :

- A Entraîne un noircissement du film sans apporter plus d'informations.
- B Diminue la fiabilité diagnostique.
- C L'utilisation de clichés centrés simples augmente ce rayonnement.
- D Est plus important dans les seins très denses.

21 En mammographie, la compression du sein :

- A Est indispensable pour diminuer le contraste.
- B Est relativement facile en cas de tissu mammaire sain.**
- C Augmente de façon sensible la dose d'irradiation.
- D Réduit de façon sensible le rayonnement diffusé.**

22 Les critères de qualité d'un cliché oblique externe en mammographie :

- A Muscle pectoral doit être visible jusqu'à hauteur du mamelon.
- B Le muscle pectoral doit faire avec le bord latéral du film un angle d'environ 45°.**
- C Le sillon sous-mammaire doit être visible sur le cliché.**
- D Le tissu glandulaire doit être bien étalé.**

23 L'Hystérosalpingographie :

- A Est indiquée en cas d'infection générale.
- B Est indiquée en cas d'infertilité secondaire.**
- C Une couverture antibiotique est systématique.**
- D Est réalisée en deuxième partie de cycle permet afin d'éviter une dissection de l'endomètre lors de l'introduction du cathéter.

24 En IRM, la pondération T2 se caractérise par :

- A Un temps d'écho est > 80 ms.**
- B Un temps de répétition > 2000 ms.**
- C Un temps d'écho est > 20 ms.
- D Un hypersignal des structures liquidiennes.**

25 En IRM, les antennes en réseau phasé :

A	Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées côte à côte.
B	Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées face à face.
C	Permettent un très bas signal sur bruit.
D	Permettent un petit champ d'exploration.

26 En IRM :

A	Le blindage des ondes de radiofréquence est assuré par la cage de Faraday.
B	Le blindage de champ magnétique a pour rôle de rapprocher les lignes de champ au plus près de l'aimant.
C	Le blindage passif de champ magnétique est un ensemble de poutrelles d'acier ou de fer doux entourant l'aimant.
D	Le blindage des ondes de radiofréquence n'est pas assuré par la cage de Faraday.

27 En IRM, le « Quench » :

A	Correspond au passage brutal de l'hélium gazeux à l'état liquide.
B	Est secondaire à un défaut dans le système d'isolation thermique.
C	Est secondaire à un non contrôle du niveau d'hélium et du bouclier thermique d'azote liquide.
D	S'accompagne d'une diminution du pourcentage d'hélium liquide présent en cuve.

28 Patient âgé de 70 ans, connu hypertendu, présente de façon brutale une hémiparésie droite, devant ce tableau clinique :

- | | |
|---|---|
| A | Une TDM cérébrale avec injection d'emblée du produit de contraste doit être réalisée. |
| B | Une TDM cérébrale sans injection du produit de contraste doit être réalisée. |
| C | Une angioIRM doit être réalisée. |
| D | Une IRM cérébrale peut être réalisée si disponible. |

29 Un uroscanner :

- | | |
|---|---|
| A | Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale. |
| B | Est indiqué devant une obstruction urinaire. |
| C | Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires. |
| D | Est contre-indiquée en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l. |

30 Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :

- | | |
|---|---|
| A | Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie. |
| B | Le Cliché sans préparation est obligatoire et permet de recherche des calcifications au niveau de l'hypochondre droit. |
| C | L'injection du produit de contraste est suivie en scopie. |
| D | L'injection du produit de contraste est progressive. |

Corrige -- Cle de reponses

N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.
1	B, D	2	A, B	3	B, C	4	C, D	5	A, C
6	B, C, D	7	B, D	8	A, B, D	9	B, C	10	A, B, D
11	A, B, C	12	A, C, D	13	A, C	14	A, C	15	B, C, D
16	A, C, D	17	A, B, C	18	B, C	19	A	20	A, B, C, D
21	B, D	22	B, C, D	23	B, C	24	A, B, D	25	A, C, D
26	B	27	D	28	B	29	A, B, C	30	A, B